L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT)

Institut de Formation dans les Métiers de la Santé et de l'Action Sociale

IFMSAS – Oujda

STE-06 : Communication adaptée en situation professionnelle

Manuel de cours

Filière :

Opérateur de Stérilisation

1ère Année

Niveau : Technicien

- TABLE DES MATIERES -

COMPETENCES-CIBLES ET OBJECTIFS OPERATIONNELS 2

CHAPITRE I QUELQUES GRAND PRINCIPES DE LA COMMUNICATION 3

1.1 Principes généraux de la communication 4

1.2 Les composantes de la communication 6

1.3 Les failles de la communication 12

CHAPITRE II LA COMMUNICATION EMPATHIQUE 13

2.1. La communication empathique 14

2.2. Bases de la communication empathique 14

2.3. Communication empathique communication professionnelle : les risques et les écueils 19

2.4. La distance professionnelle 26

2.5. Le bon positionnement au sein de l'équipe de soins 29

CHAPITRE III VOCABULAIRE TECHNIQUE 32

3.1. TERMINOLOGIE MEDICALE 33

3.2 Vocabulaire technique 38

COMPETENCES-CIBLES ET OBJECTIFS OPERATIONNELS

Module 06 : COMMUNICATION ADAPTEE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Code : STE – 06 **Durée : 45 heures**

ENONCE DE LA COMPETENCE

Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit être capable d'adopter un mode de communication empathique, à analyser une demande et apporter une réponse appropriée.

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE

- Communication empathique avec le patient
- Maîtrise des registres de communication
- Respect des droits du patient

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

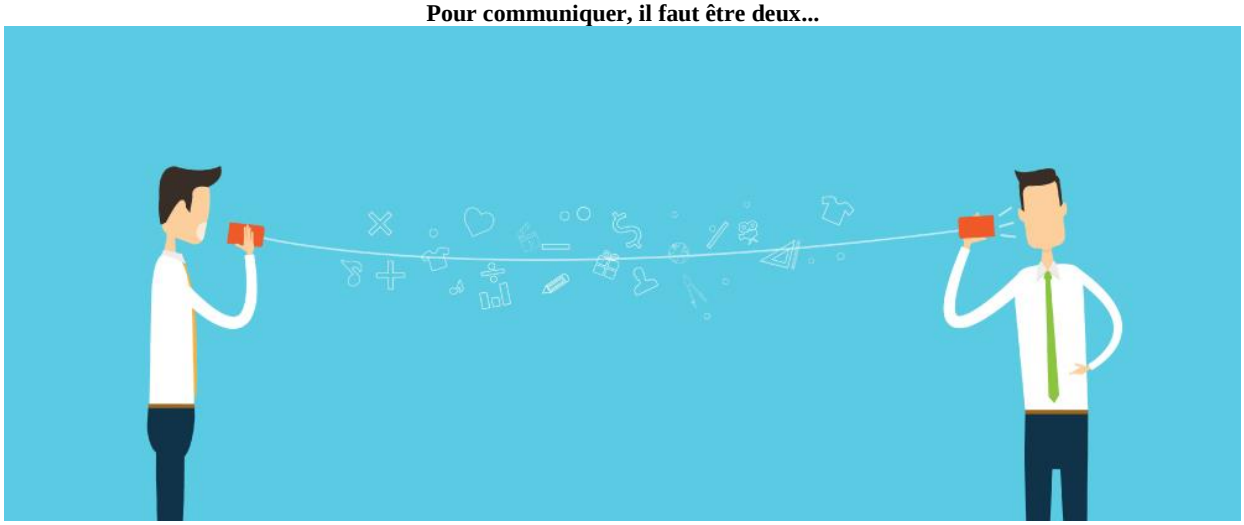
ÉLEMENTS DE LA COMPETENCE	CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE
A. Utiliser le français technique professionnel	- Expression claire - Orthographe correcte - Utilisation à bon escient des termes médicaux
B. Appliquer le vocabulaire anglais technique professionnel	- Capacité à tenir une conversation simple - Utilisation à bon escient des termes médicaux
C. Écouter le patient et son entourage et prendre en compte les signes verbaux et non verbaux de communication	- Écoute empathique - Écoute active - Observation fine et neutre
D. Comprendre et reformuler l'expression de l'interlocuteur, apporter les informations et les réponses attendues	- Niveau de langage adapté à l'interlocuteur - Secret professionnel respecté, - Mise en œuvre de discrétion - Capacité à reformuler - Délivrance pertinente des informations nécessaires - Explications pertinentes données au patient
E. Identifier les limites de son champ d'intervention	- Positionnement juste par rapport aux situations de crise ou de violence - Connaissance juste des limites de son champ d'intervention - Stress géré

Chapitre I

PRINCIPES DE LA COMMUNICATION

1.1 Principes généraux de la communication

Pour communiquer, il faut être deux…

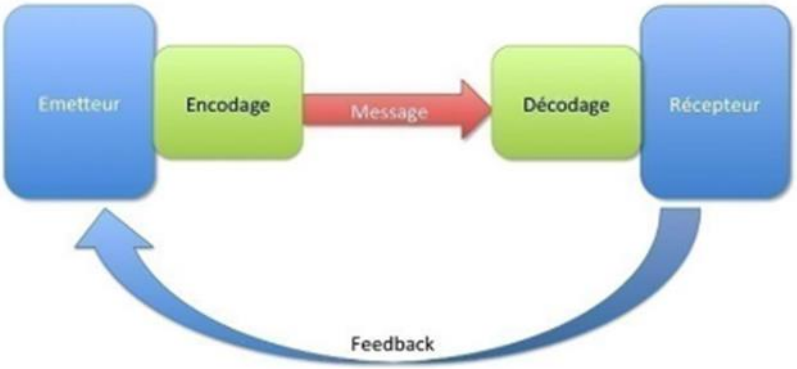


Un émetteur,

le message,

un récepteur…

Mais c'est beaucoup moins simple que cela parait.



Une information, même simple, est « préparée » par l'émetteur : encodage
Elle est entendue, bien ou mal, mais elle est toujours « retravaillée » par le récepteur : décodage.
Et sa manière de comprendre, ou pas, ou déformer le message va avoir un effet en retour sur l'émetteur : feedback.
Le contexte de la communication est décisif (on est en forme ou pas, on entend bien ou pas, on est pressé ou on a le temps, on a confiance dans l'interlocuteur ou pas etc.)
Et puis il y a ce que disent le corps, les yeux, les attitudes de l'un comme de l'autre !

LES COMPOSANTES DE LA COMMUNICATION

NON VERBALE		VERBALE
PARA-VERBALE	**INFRA-VERBALE**	
Attitudes et Gestes	**Parole**	**Forme et contenu**
- Image que l'on donne (aisance) - Espace utilisé - La gestuelle - Le regard - Les mimiques - La respiration - L'utilisation du support écrit	- Voix : . Volume . Débit . Rythme . Articulation . Prononciation . Intonation - Les pauses, les silences - La respiration	- Clarté de la pensée et des idées émises - Organisation des idées - Le langage - Le vocabulaire - Le temps dont on dispose

Pour communiquer, il faut donc :

Etre **VU** puis **ENTENDU** pour être **COMPRIS**

En situation de communication, - 20 % des informations transmises est porté par les mots (**verbal**)
- 80 % des informations transmises est porté par le non-verbal
(30 % d'infra-verbal et 50 % de para-verbal)

Source : AP-HP - IFSI Charles Foix

Communiquer parait la chose la plus simple et la plus naturelle du monde, il suffirait d'apprendre à parler….
Alors que c'est l'une des plus complexes.
Par ailleurs, le receveur du message doit également être dans une attitude propice à l'écoute.
« Le plus grand problème dans la communication, c'est qu'on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour répondre ».

Il y a certes des capacités personnelles, des attitudes qui ne s'apprennent pas : chacun a son caractère, sa façon d'être avec les autres.

Mais dans un contexte de soins, d'abord personne ne peut rester dans son coin, quel que soit le métier pratiqué, car tous impliquent des relations aux patients d'une part et des relations d'équipe d'autre part.

Ces relations vont par ailleurs beaucoup plus loin que le « vivre ensemble » de tout un chacun, elles ont un contenu professionnel et leurs qualités influent sur la qualité du service rendu : elles relèvent d'une compétence, avec des connaissances, des savoir-être et des savoir-faire.

C'est l'objet de ce module de formation.

1.2 Les composantes de la communication

On a vu plus haut qu'il existe le verbal et le non verbal…

1.2.1 Communication verbale

LE VERBAL correspond aux mots qui sont prononcés, leur sens et leur signification.

1.2.1.1 Précision du vocabulaire

S'agissant de santé, les mots ont un sens précis, qu'il s'agisse de définir un outil, un instrument, un symptôme, une pathologie. La signification de ces mots n'est compréhensible que dans la langue où ils sont prononcés : c'est pourquoi une partie de ce module sera consacré aux termes médicaux, en arabe mais aussi en français et en anglais, le Maroc étant un pays d'accueil (sans parler du public croissant de ce qu'on appelle le « tourisme médical »).

Même lorsqu'on maîtrise une langue, dire simplement et clairement les choses, comprendre la totalité et l'exactitude de ce qu'a voulu dire son interlocuteur n'est pas simple.

Mais la communication est un art qui se pratique à deux : il y a des moyens très simples de vérifier qu'on a été bien compris ou qu'on a bien compris, ce sont des techniques de communication.

Parmi ces techniques, le professionnel peut utiliser « les reflets », cela consiste à dire en d'autres termes, et de manière plus explicite ce que l'interlocuteur vient d'exprimer.

Pourquoi les utiliser ? Afin de montrer au patient qu'il est compris et entendu, et de l'encourager à s'exprimer.

1.2.1.2 Réitération

Répétition de ce qui a été dit, permet de résumer, paraphraser, accentuer la communication.

Ex : le patient : « je suis inquiet, je ne sais pas si je vais voir ma fille, vous comprenez, je n'ai pas pu parler avec elle, mais s'il n'y a pas de visites, vous comprenez, je ne sais pas si on a le droit ».

Le soignant : « je comprends, vous voulez savoir si vous avez le droit aux visites ».

1.2.1.3 Reformulation

Permet de favoriser l'accès du patient à ses émotions, identifier et nommer l'émotion, le ressenti de la personne, prendre conscience des émotions et pouvoir aller plus en profondeur dans l'entretien patient / soignant.

La phrase peut commencer par :

« Ce que je comprends… »

« Si j'ai bien compris… »

« Ce que vous me dites c'est que… »

Cela permet au patient de prendre conscience que le soignant infirmière fait l'effort de comprendre ce qu'il a voulu dire et n'interprète pas ses dire. Pour cela le soignant reprend les mots significatifs de la personne, cela permet de renter dans son monde d'émotion mais cela permet aussi permet à la personne de réfuter ce que l'on a dit, de nuancer notre compréhension ou de valider notre formulation.

Ex : le patient : « Ça fait un moment que je ne sors plus, j'ai un mal de chien à me lever et à sortir de mon fauteuil, quand je suis debout ça va »

L'intervenant : « Vous voulez dire que vous avez des douleurs dans le dos qui vous empêchent de vous redresser »

Il existe d'autres techniques de communications, telles que :

La synthèse, qui a pour but de montrer à l'interlocuteur qu'il est compris et entendu et de remettre de l'ordre dans le contenu qu'il a exprimé. La synthèse est une manière de reformuler.

Le questionnement permet d'obtenir des précisions, d'explorer un contenu jugé important, de faire répéter ce qui n'a pas été compris et d'obtenir de nouvelles informations.

Les questions peuvent être ouvertes :

- Vous ne vous sentez pas bien, vous avez mal quelque part ?

Elles peuvent être fermées : elles seront généralement focalisées sur un point précis, avec une réponse par OUI ou NON

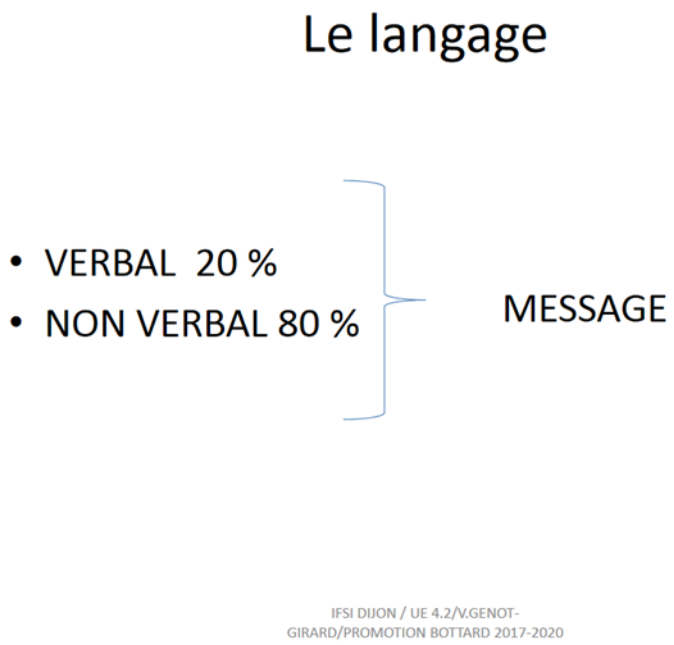
- ça vous fait mal quand je vous touche le genou ?

Attention aux questions dirigées qui contiennent une réponse, qui est votre interprétation, peut être fausse.

1.2.2 Communication non verbale

Selon le non-verbal qui l'accompagne, un mot peut prendre un autre sens que son sens normal.

Par conséquent, si la signification des mots est leur sens premier (objectif), leur sens accompagné du non-verbal est leur signification cachée, plus subjective, liée au contexte.



On communique avec des mots mais aussi avec ses gestes et ses mimiques.

> *Si vous n'êtes pas conscient des changements subtils qui s'opèrent dans la voix, dans le langage corporel et dans les expressions faciales de votre interlocuteur, vous ne pourrez pas déterminer avec certitude ce que l'autre pense ou ressent, car certains indices vous échapperont. Vous ne saurez pas si cette personne comprend ce que vous lui dites, ni même si elle vous écoute vraiment.*
>
> **La clé de la communication**
> **Découvrez la puissance de l'empathie**
> *Andrew B. Newberg Mark Robert Waldman*
> *Editeur : Les Editions de l'Homme*
> *Parution : juin 2013*

1.2.2.1 Communication infra verbale

On est toujours dans les mots exprimés, mais il y a la manière de les exprimer…

Chacun sait que le ton employé pour dire les mêmes mots peut en changer totalement la signification.

Entre « Tu vois ce que je veux dire ? » d'un ton interrogatif et doux, la main sur l'épaule, simple question de vérification de la bonne entente, et « Tu vois ce que je veux dire » d'un ton menaçant, poing tendu, menace clairement exprimée, pas grand-chose à voir…

1.2.2.2 Communication non verbale

C’est tout ce qui ne passe par les mots mais par les gestes, le regard, l’attitude corporelle.

Quelques types de communication non verbale permettent au patient de se sentir en confiance, soutenu, compris, et entendu :

- Le regard : le soignant regarde son interlocuteur dans les yeux sans pour autant le dévisager. Il n'y a rien de plus irrespectueux et blessant que de regarder ailleurs quand quelqu'un s'adresse à vous.
- La distance : le soignant doit se tenir à la bonne distance, pour que l’interlocuteur ait un sentiment de proximité (et sois sûr d’être entendu, sans avoir à crier et être entendu de toute la salle) mais pas non plus être trop près. Le soignant reste un professionnel, c’est ce qu’on appelle la distance thérapeutique.
- La position physique : par exemple pour un entretient, assis sur une chaise, bras non croisés, sinon l'image renvoyée pourrait être la fermeture à toute communication. C’est ce qu’on appelle le langage du corps.

- Le silence : peut être perçu positivement comme une invitation à poursuivre un dialogue. Il ne doit tout de même pas être trop fréquent.
- Le toucher : selon les cultures, serrer la main de son interlocuteur pour lui dire bonjour peut être un moyen de lui montrer qu'il a droit à une certaine considération et peut aussi permettre un rapprochement.

La communication non verbale n’est pas facile à maîtriser : les mises en situation filmées et analysées en groupe sont un bon moyen de se rendre compte de sa manière non verbale de communiquer et de l’améliorer, car on en est rarement conscient.

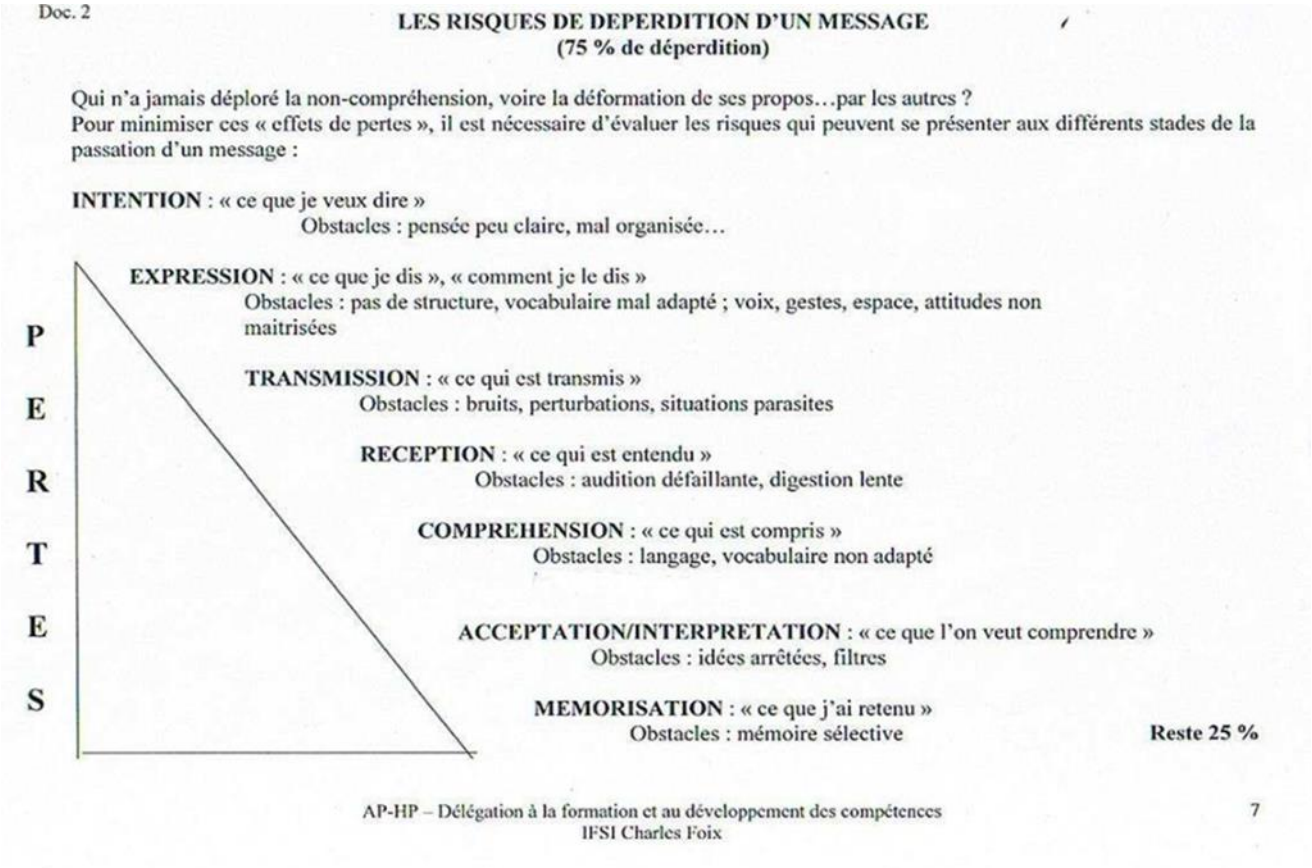
1.3 Les failles de la communication

Chacun sait qu'entre ce qu'on veut dire et ce que l'interlocuteur comprend il y a la plupart du temps une très grande différence…

Certains psychologues ont traduit cela par une image, celle d'une série de filtres, qui réduisent peu à peu la signification du message que l'on voulait faire passer.

Il y a en effet successivement :

1. Ce que je pense
2. Ce que je veux dire
3. Ce que je dis
4. Ce que l'interlocuteur entend
5. Ce que l'interlocuteur écoute
6. Ce que l'interlocuteur comprend
7. Ce que l'interlocuteur accepte
8. Ce que l'interlocuteur retient
9. Ce que l'interlocuteur fait du message qu'il a retenu



Ainsi, il ne resterait à la fin en moyenne que le quart du message initial. D'où la nécessite de répétition, reformulation, vérification de la réception etc…

Chapitre II
LA COMMUNICATION EMPATHIQUE

2.1. La communication empathique

La relation soignant-patient s'établit sur une base qui n'est pas égalitaire : le patient attend d'être soigné, il a besoin de l'intervention du soignant, dépositaire du savoir et de la compétence pour le faire. En plus, il est la plupart du temps en position de faiblesse, de souffrance ou de malaise.

Mais le soignant, s'il veut être efficace, qu'il s'agisse de diagnostic, de soins ou services à prodiguer (comme l'aide au levage, les soins d'hygiène, le brancardage, les soins infirmiers etc.), aura beaucoup plus de facilité s'il peut écouter le patient, dialoguer avec lui.

La communication est nécessaire, mais elle est « mal engagée » puisque non égalitaire entre soigné et soignant.

C'est au soignant de faire en sorte que cette communication se mette en place dans les meilleures conditions : ce sont les termes ce que l'on appelle « la communication empathique ».

2.1.1. Définitions

Empathie *(du grec pathos, qui désigne passion, souffrance, maladie) : faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent.*

PHILOSOPHIE : l'empathie est fondée sur un accord spontané avec le ressentir de l'autre. Cette participation affective peut donner lieu à une fusion affective. Si elle se double d'un sentiment de réciprocité affective, elle devient sentiment de sympathie.

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE : l'empathie, plus que la sympathie, qui repose sur une similitude harmonieuse de sentiments, est un phénomène permettant de « se mettre à la place » de l'autre. L'apprentissage social favorise son développement en permettant l'acquisition de réactions codifiées (règles de politesse, fêtes avec échanges de cadeaux, réactions altruistes, etc.). Le défaut d'empathie s'observe chez certains sujets froids et fermés, schizoïdes ou obsessionnels. Son absence ou son exagération chez un sujet jeune annonce parfois l'installation d'un processus schizophrénique. Les oscillations de l'empathie, avec passage d'un extrême à l'autre, constituent la toile de fond du caractère cyclothymique (alternance de périodes d'excitation et de dépression) ; elles sont néanmoins banales au cours de l'adolescence.

Dictionnaire Larousse

Dans la relation inégale entre, schématiquement, un patient qui souffre et un soignant qui est là pour le soigner, la communication dite « empathique » est celle du soignant qui rétablit un semblant d'égalité en signifiant qu'il « partage » la souffrance du patient.

L'empathie, plus que la sympathie, qui repose sur une similitude harmonieuse de sentiments, est un phénomène permettant de « se mettre à la place » de l'autre. L'apprentissage social favorise son développement en permettant l'acquisition de réactions codifiées (règles de politesse, fêtes avec échanges de cadeaux, réactions altruistes, etc.). Le défaut d'empathie s'observe chez certains sujets froids et fermés, schizoïdes ou obsessionnels. Son absence ou son exagération chez un sujet jeune annonce parfois l'installation d'un processus schizophrénique. Les oscillations de l'empathie, avec passage d'un extrême à l'autre, constituent la toile de fond du caractère cyclothymique (alternance de périodes d'excitation et de dépression) ; elles sont néanmoins banales au cours de l'adolescence.

Article Empathie et communication de Jacques Cosnier

Dans **La Communication** (2016, Éditions Sciences Humaines)

2.2. Bases de la communication empathique

Pour « partager » la souffrance de l'autre, il faut l'entendre. Pour cela la première base est l'écoute…

2.2.1.1. L'écoute attentive

Quelques bases :

Développer et montrer sa disponibilité : Afficher un vrai « oui je vous écoute », créer un climat de sécurité et de confiance afin que celui qui parle se sente rassuré. Vous pouvez le montrer avec vos mots et avec votre attitude non-verbale (gestes de civilité, ouverture du corps, regard, …) mais aussi en fermant ou cachant tout ce qui est susceptible de distraire vos attention (portables etc.) et parfois aussi en vous isolant lorsque cela est possible (en fermant une porte par exemple).

Exprimer de l'empathie. Il s'agit de se mettre, pendant le temps de l'entretien, en quelque sorte « dans les chaussures » de l'autre. Cela n'implique pas d'être d'accord avec cette personne, ni de chercher à devenir son ami(e) mais d'essayer de comprendre son point de vue. Pour cela il faut chasser ses préjugés (exemple : il (ou elle) exagère, ça ne fait pas si mal), ne pas concevoir à l'avance une réponse (exemple : je sais ce que vous ressentez, mais ce n'est pas grave). Simplement écouter et laisser venir.

Voir au-delà des mots. Certaines personnes s'expriment plus facilement que d'autres. Pour s'assurer d'avoir bien compris les mots, il faut observer la communication non verbale de l'interlocuteur. La personne en face de vous essaie de mettre en mots ses émotions et ressentis, ou tente au contraire de les masquer (exemple : non je n'ai pas si mal – tout en grimaçant et se tortillant sur sa chaise).

Arriver à ne pas exprimer de jugement (c'est souvent le plus dur). Nous sommes tous tentés de donner des conseils basés sur notre expérience pour « aider » quelqu'un qui a un problème. Ne donnez pas votre avis, il contient bien souvent un jugement. L'autre doit se sentir écouté et compris. Il n'est pas venu vous voir pour être jugé. Et s'il vous faut exprimer une critique, rappelez-vous que vous devez vous limiter à remettre en question ce que la personne a fait, mais pas ce qu'elle est.

Pratiquer la reformulation. Avec vos mots, vous pouvez montrer que vous avez compris, ce qui rassure votre interlocuteur.

Les bénéfices de la communication empathique.

2.2.1.2. Ce que l'écoute attentive n'est pas

On peut citer :

- l'écoute flottante (avoir la tête ailleurs quand on nous parle),
- la délibération intérieure (débattre les propos de l'autre en son for intérieur),
- le jugement (se laisser influencer par des opinions négatives),
- la résolution de problèmes (vouloir donner immédiatement des conseils non sollicités au stade de l'écoute),
- la pseudo-écoute (faire semblant d'écouter attentivement, si ce n'est pas le cas cela sera vite perçu et la relation de confiance s'effondrera),
- la mise en vedette (toujours rediriger la discussion vers soi, en fonction de ses propres objectifs),
- l'écoute piégée (écouter uniquement pour recueillir de l'information susceptible d'être utilisée contre l'autre),
- l'écoute sélective (ne répondre qu'aux parties de la conversation qui nous intéressent),
- l'écoute défensive (concevoir les propos de l'autre comme une menace personnelle),
- l'écoute fuyante (faire abstraction de tout ce qu'on ne veut pas entendre).

Certains de ces principes semblent évidents, pourtant très peu de gens arrivent à communiquer de cette manière. On peut savoir "en théorie" quelle approche appliquer pour rendre la communication plus fluide mais passer de la théorie à la pratique est très difficile, dans la vie personnelle comme professionnelle.

Modifier un comportement nécessite du temps et de l'entrainement, en s'autorisant des échecs et une expérimentation par tâtonnement, car chacun, finalement, développera son approche, avec peut-être des tics de langage ou de comportement qui lui sont propres.
Mais dans les métiers de santé on n'expérimente pas sur les malades, on se forme d'abord, en théorie mais aussi en pratique, dans des situations simulées, des exercices réalisés en groupe !

Le regard des autres, l'évaluation et les conseils du formateur peuvent aider. Le regard sur soi peut beaucoup aider : il ne faut pas hésiter à se laisser enregistrer, afin de pouvoir se regarder et s'écouter, ce qui révèle bien souvent des surprises !

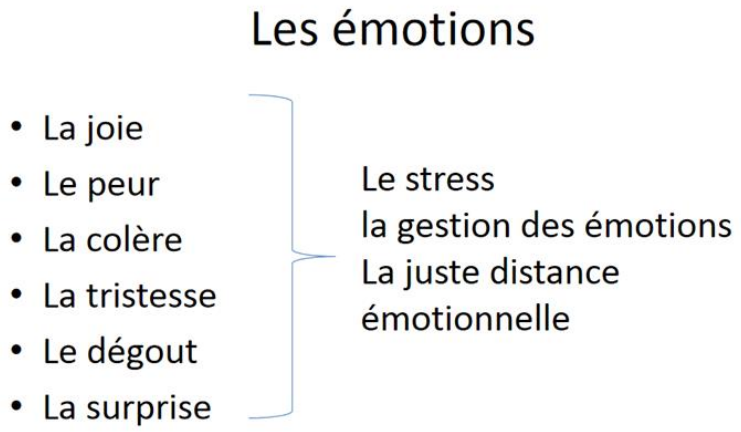
2.3. Communication empathique communication professionnelle : les risques et les écueils

Partager en permanence la souffrance des autres, c'est se mettre en danger.
À court terme, c'est perdre son efficacité professionnelle.

2.3.1. Communication empathique communication professionnelle : les risques et les écueils

2.3.1.1. L'effet miroir des émotions

Les émotions du patient évoquent chez le soignant des éléments de son histoire personnelle, et risquent donc de le faire sortir de sa neutralité et de son efficacité, notamment en contribuant à son stress (par exemple : un patient en fin de vie fait penser à son père).



C'est ce qu'on appelle l'effet miroir ….

Les émotions interviennent dans la relation soignant/soigné.
Le soignant doit pouvoir les maitriser ou au mieux les gérer, mais pour autant cesser de percevoir celles du patient.

Sous le coup de l'émotion soudaine, le soignant risque d'être paralysé, ou de ne pas prendre les bonnes décisions au bon moment. Des mises en situation, durant la formation, sont le meilleur moyen de se préparer face à des situations imprévues, stressantes ou émouvantes.

L'exercice est difficile. Lorsqu'un soignant prend en charge un patient, perception sensorielle, émotions passagères, sentiments durables et cheminement cognitif* sont si étroitement mêlés que le soignant a parfois du mal à les identifier distinctement.

* Le cheminement cognitif est pour schématiser ce que dicte la raison en vue d'une action

2.3.1.2. Réactions inconscientes de défense du soignant

Les émotions du patient évoquent chez le soignant des éléments de son histoire personnelle, et risquent donc de le faire sortir de sa neutralité et de son efficacité, notamment en contribuant à son stress (par exemple : un patient en fin de vie fait penser à son père).

Il est important pour le soignant de garder au maximum le contrôle sur lui-même et ses émotions : dans ce contexte il n'est pas inutile d'indiquer quelques réactions de défense (généralement complètement inconscientes relevées chez des soignants).

- Technicisation : la technique, les protocoles sont un refuge
- Banalisation : évite l'envahissement émotionnel
- Mensonge : masquer la vérité pour éviter d'affronter les réactions du patient
- Fausse réassurance : donne de faux espoirs au patient
- Esquive : parler de tout et de rien pour éviter que le patient n'exprime sa souffrance.
- Déni : le soignant ignore la gravité du trouble car c'est trop intolérable pour lui.
- Rationalisation : émotionnel étouffé derrière des raisonnements
- Dérision : mise à distance des émotions
- Identification projective : établissement d'un rapport fusionnel avec le patient sur la base d'un vécu partagé.

Ces réactions de défense peuvent conduire à des comportements inappropriés chez le soignant, par exemple :

- Un comportement qui ne traduit ni l'acceptation, ni le respect,
- La non-reconnaissance de la personne soignée et de ce qu'elle vit
- Une attitude froide et indifférente, un air pressé ou ennuyé
- Des réponses fermées sans tenir compte des besoins ou des tentatives de communication du patient
- Des paroles et des réponses brusques ou inappropriées
- Le recours à des faux-fuyants : généralisations, échappatoires
- Un comportement dominateur, suffisant ou paternaliste, preuve d'un manque de considération.

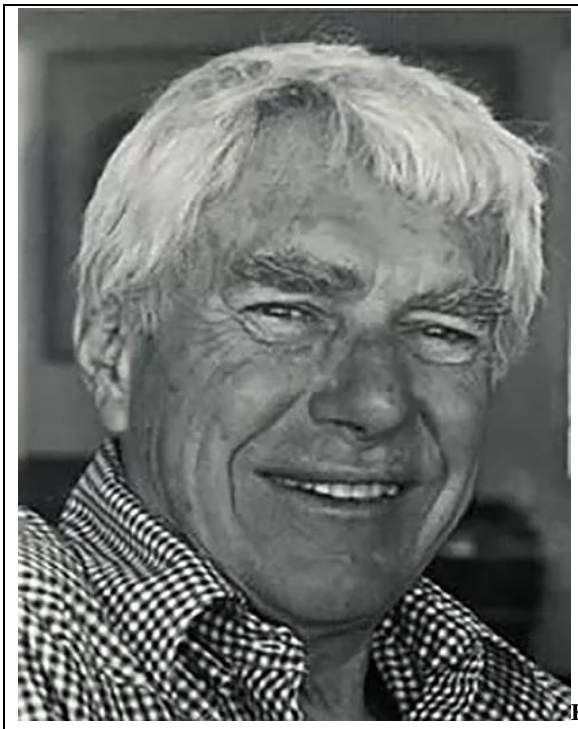
Source : Cours en ligne 4.2 De la distance à la proximité, site EIDE

Le soignant doit donc prendre garde à ses propres émotions : tout est affaire de distance…

Il existe justement une science qui étudie les distances (physiques) dans les relations sociales.

2.3.1.3. Distance et proxémie

Cette notion de distance dans la relation sociale a été définie sous un nom scientifique : la proxémie.



Edward T. Hall, est un anthropologue américain qui s'est intéressé aux distances sociales, créant le concept de proxémie. La définition simplifiée c'est « l'ensemble des observations concernant l'usage que l'humain fait de l'espace qui l'entoure et le sépare des autres ». L'un des concepts majeurs en est la distance physique qui s'établit entre des personnes prises dans une interaction.

Le chercheur a pu déterminer quatre distances dans l'expérience humaine et ce qui les distinguait les unes des autres :

- **Distance publique**
- **Distance sociale**
- **Distance personnelle**
- **Distance intime**

- **Distance publique (au-delà de 3,60m)** : les personnes sont plus ou moins éloignées les uns des autres. Si on s'éloigne, la silhouette est moins nette, le corps perd son volume et les détails des mouvements ne sont plus perceptibles, les détails du visage en particulier deviennent imperceptibles « *Il y a peu d'interaction à cette distance : la communication est avant tout verbale* ». Pour se parler, il faut lever la voix et les nuances se perdent.

- **Distance sociale (de 3,60m environ à 1,20m)** : les deux interlocuteurs communiquent verbalement. Ils parlent à voix haute et entretiennent un contact visuel. On retrouve cette distance dans les relations de voisinage, les rencontres professionnelles, commerciales ou lors des débuts d'une consultation médicale par exemple. Au niveau de la distance physique, il y a au moins 1,20m qui sépare les deux personnes, elles ne peuvent donc pas se toucher. L'échange reste verbal « *car les protagonistes sont en interaction avec des mots et non directement avec leur corps* ». Par rapport aux compétences qui sont développées dans les programmes de formation, cette distance peut correspondre à la situation où pourra être développée celle visant à « Evaluer l'état initial d'un patient », sans contact, sans examens complémentaires.

- **Distance personnelle (de 1,20m à 45cm)** : les personnes peuvent se toucher l'autre car la distance physique est réduite. « *Le corps de l'autre est là, à portée de main, et il va de soi qu'on ne tolère sa présence que s'il y a un degré maximal de confiance pour ne pas craindre un mauvais coup ou tout geste qui ne nous conviendrait pas* ». On peut retrouver cette distance dans les relations amicales. La tonalité de la voix est moins élevée. Le corps n'est plus perçu dans sa totalité mais nous arrivons à en observer plus précisément certaines parties du corps.
  Cette distance, qui est celle du dialogue, toujours sans contact, permet d'affiner l'évaluation de « l'état initial d'un patient ».

- **Distance intime (de 45cm jusqu'au contact physique)** : toujours dans cette classification établie par Edward T. Hall sur les relations sociales, la communication est principalement non verbale, avec peut-être des mots échangés mais sans constituer un véritable dialogue qui se fait, selon lui, dans un murmure. Les sens utilisés changent, la vue peut laisser place au toucher et à l'odorat. « *La dimension non verbale l'emporte sur la communication verbale, et le contact physique.* ».

  Cette distance intime est à rapprocher selon lui de trois contextes différents :
  - la violence lorsque deux personnes se battent et font un corps à corps ;
  - la rencontre amoureuse;
  - l'attitude de soutien, de protection, de tendresse.

Ces catégories sont bien antérieures aux phénomènes sociaux que constituent-les :

Réseaux sociaux, d'une part

qui créent une intimité virtuelle sans contact physique, et

Les effets de la pandémie du coronavirus
Dont les fameux « gestes barrière »…

Le chercheur, qui identifie toujours très clairement l'échantillon de population étudiée, a rapidement mis en lumière les variations importantes dans l'usage de ces distances sociales.

Bien sûr, en situation professionnelle dans les métiers de soin, au-delà du premier contact et du premier entretien, la distance dite « intime » est celle qui s'observe dans les activités de soutien (aide au relevage, aide à l'installation, en fauteuil, en brancard, en préparation d'examen, aide à la marche par exemple), mais aussi dans les soins d'hygiène et de confort et dans les soins infirmiers.

Le soignant doit franchir cette barrière de l'intime, qui répond à une codification sociale très forte, mais sans devenir pour autant un intime du patient.

C'est un enjeu fort, qui passe par la communication.

Expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait…

Il n'y a pas de règle universelle en matière de distance sociale : les distances interpersonnelles peuvent être très différentes selon les cultures et religions. Le même chercheur, Edward T. Hall, a étudié ces différences : « un Italien est proche de son interlocuteur, il s'exprime facilement avec des gestes, voire des contacts » contrairement à : « un Anglais qui, traditionnellement, ne touche pas son interlocuteur et ne s'en approche pas autant. »

Edward T. Hall a donc remarqué que ces distances varient selon les cultures considérées. Ainsi, dans les pays latins, les distances entre les corps sont relativement réduites. En Afrique, elles sont souvent si réduites que le contact physique est fréquent. À l'inverse, dans les pays nordiques ou au Japon, les contacts physiques sont plus rares et ces distances plus importantes. Elles varient également selon les lieux où l'interaction se déroule, ce qui signifie qu'elles doivent être prises en compte par les architectes et designers. Elles sont par exemple différentes dans des lieux publics comme les ascenseurs ou les transports en commun.

Et au Maroc

Au Maroc, selon une observatrice qui se réfère aux travaux de Edward T. Hall, *la proxémie marocaine est déstabilisante pour l'étranger : on oscille entre le très proche et le très loin*. Cela dépend du sexe, plus que de la réelle relation avec la personne. D'un point de vue occidental, les Marocains se conduisent avec vous comme des amis très proches, même si le mot n'a pas le même sens. Autant les relations entre les personnes du même sexe peuvent être physiquement proches, autant celles entre hommes et femmes sont physiquement distantes, même s'ils sont intimes (mari et femme, frère et sœur), et cela dès le plus jeune âge. Il s'agit avant tout de respecter la pudeur. Ces distances perdurent à la maison, alors qu'on est dans le cercle de l'intime.

La pratique religieuse encourage cette proximité physique (entre hommes). A la mosquée, il faut être en rang serrés (les places sont souvent imprimées pour matérialiser les tapis de prière) et on doit compléter le rang avant d'en commencer un autre.

Informations extraites de l'article du 25 mai 2020 « Distanciation sociale au Maroc, l'impossible acculturation ? » dans Vivre et travailler au Maroc. Références dans la bibliographie.

Pour aller plus loin, bibliographie :

Yves Winkin, La Nouvelle Communication, Paris, Seuil, coll. « Points / Essais », septembre 2000.

Et un article très intéressant sur le Web https://o-maroc.com/distanciation-sociale-impossible-maroc dans **O-Maroc Vivre et travailler au Maroc**, partage d'info, L'article du 25 mai 2020 « Distanciation sociale au Maroc, l'impossible acculturation ? » fait notamment le point sur les effets de la crise du COVID dans le pays.

2.4. La distance professionnelle

Partager en permanence la souffrance des autres, c'est se mettre en danger.

Il faut pourtant se rapprocher, pour apporter son aide ou administrer des soins, en franchissant la barrière de l'intime.

Mais se rapprocher de l'autre implique de franchir des frontières invisibles, qui dépendent de la culture du soignant comme du soigné.

Au niveau des sentiments comme au niveau des gestes, existe-t-il une « bonne distance » ?

2.4.1. Définition

Une définition proposée est « la limite morale et psychologique à l'expression des valeurs personnelles dans le cadre de l'activité professionnelle ».

Il s'agit de trouver le bon équilibre entre implication (se noyer dans la souffrance et les émotions de l'autre) et "autoprotection" individuelle (se fermer aux émotions de l'autre pour se protéger). Cette distance « juste » n'est pas universelle, elle dépend notamment la culture du soignant comme du soigné mais elle dépend essentiellement de l'identité du soignant, personnelle et professionnelle (son histoire, son fonctionnement et ses principes). Cette distance préservée peut être appelée « carapace professionnelle » par E. Mallem*

*MALLEM, Elke. La distance professionnelle, Objectif Soins, n°136, mai 2005

En quelque sorte le soignant se forge un bouclier qui lui permet de se protéger des émotions de la personne qu'il soigne.

Carapace ou pas, affiche pour la protection des espèces menacées après les incendies….

2.4.2. La « juste » distance

Une définition serait comme « la capacité à être au contact d'autrui malgré la différence des places » selon Pascal Prayez*

* PRAYEZ, Pascal ; SLIWKA, Corinne (sous la coordination de). *Distance professionnelle et qualité du soin.* France : Lamarre. 2018°

Cette bonne distance implique d'être pleinement conscient des enjeux émotionnels et affectifs, mais aussi des intérêts éthiques qu'entraîne cette relation interpersonnelle. Ainsi, pour mettre en place une distance juste avec le patient, il faut que le soignant soit, selon Pascal Prayez, dans « *l'intention juste* », c'est-à-dire en ayant la volonté de trouver un certain équilibre entre ce qu'il veut apporter à l'autre, et ce que celui-ci est en droit d'attendre en tant que patient.

Le soignant doit établir un lien interactif avec la personne soignée qui lui permet à la fois d'être au contact de son ressenti, de ses émotions, tout en conservant suffisamment de distance afin de pouvoir les analyser. Il pourra ainsi préserver son intégrité psychique et son bien-être dans le cadre de l'exercice de sa profession.

« Trouver et gérer la "bonne" distance thérapeutique est une sécurité psychologique » pour le soignant et le soigné selon M. Liégeois*. Cette distance diffère pour chaque individu selon ses propres limites. Il faut trouver le juste équilibre entre le « risque de tomber dans une relation de type fusionnel » et le risque d'être si distant que l'on ne peut « rien entendre de la souffrance » du patient. Il affirme que « prendre du recul pour mieux écouter et mieux accompagner ».

LIÉGEOIS, Maurice. Distance thérapeutique. Article mis en ligne par le Serpsy (Soin Etude et Recherche en Psychiatrie, Espace de réflexion et d'échanges autour de la relation soignant / soigné) Disponible sur : <http://www.serpsy.org/detour/distance.htm

La bonne distance professionnelle est celle qui permet une communication de qualité avec le patient, et donc une écoute attentive de ses besoins, mais également de sa souffrance, la juste distance est celle qui assure de tenir la souffrance à un niveau qui permette de travailler avec elle.

La relation de confiance soignant - soigné

Plus le soignant et le patient sont dans une relation saine, juste, qui respecte leurs individualités et leurs statuts, mieux ils parviendront à construire une relation de confiance.

Ce lien privilégié s'appelle d'ailleurs le « colloque singulier »

Importance de la communication soignant-soigné

• Diminution du nombre d'erreurs

• résultats thérapeutiques améliorés

• informés et éduqués sur leur traitement et leurs médicaments.

NB: Une mauvaise communication entre les professionnels de santé, les patients et leur entourage est aussi devenue un motif habituel de poursuites judiciaires intentées par les patients à l'encontre de leurs professionnels de santé.

Une relation de soins nécessite souvent du temps.

Temps qui n'est pas forcément disponible dans une relation d'aide et de soutien (par exemple pour un brancardage), où la relation devra être quasiment immédiate, dès la présentation et les explications de l'intervenant.

Pour le soignant (ou l'accompagnant sur un temps plus long, par exemple un transfert hospitalier entre établissements éloignés) il s'agira de manifester sa disponibilité et son intention sincère de répondre aux besoins et aux attentes du patient.

Dans une relation de soins, au fur et à mesure du renforcement de cette relation de confiance, le soignant et le patient en viennent à former une véritable « alliance thérapeutique », à un accord par engagement mutuel du soignant et du soigné qui cheminent ensemble vers un même objectif, la guérison ou le mieux-être du patient. Le soignant effectue tous les soins permis dans les limites de sa fonction, en étant disponible et à l'écoute. Le patient respecte scrupuleusement le traitement prescrit et les recommandations concernant son hygiène de vie.

La principale difficulté dans la recherche de cette juste distance reste de parvenir à installer des limites dans la relation, et à les maintenir tout au long de la prise en charge. Ces limites peuvent être soulignées dans le dialogue, en maintenant par exemple le vouvoiement et les formules de politesse.

Malgré ces barrières assez factices, une dimension affective peut se développer, qui peut amener un soignant et son patient à s'estimer, s'apprécier, puis finalement s'attacher l'un à l'autre. L'attachement peut être assimilé à un engagement, un sentiment qui lie, unit fortement à quelqu'un. L'attachement est un besoin primaire de l'homme, naturel, comme l'enfant avec ses parents dès la naissance. Chaque individu est construit de telle sorte qu'il a tendance à s'attacher aux personnes en lesquelles il a confiance, auxquelles il a dévoilé son espace intime et qui lui procurent un sentiment de sécurité et de bien-être.

Évaluer son degré d'attachement à une personne est difficile. Mais c'est indispensable pour le soignant s'il veut mettre en place une juste distance avec un patient (et ne pas être dévasté chaque fois que des soins n'aboutissent pas…)

Tout l'enjeu pour le soignant se trouve là : trouver le juste équilibre entre proximité relationnelle et attachement.

La bibliographie sur le sujet est très vaste, on peut retenir principalement

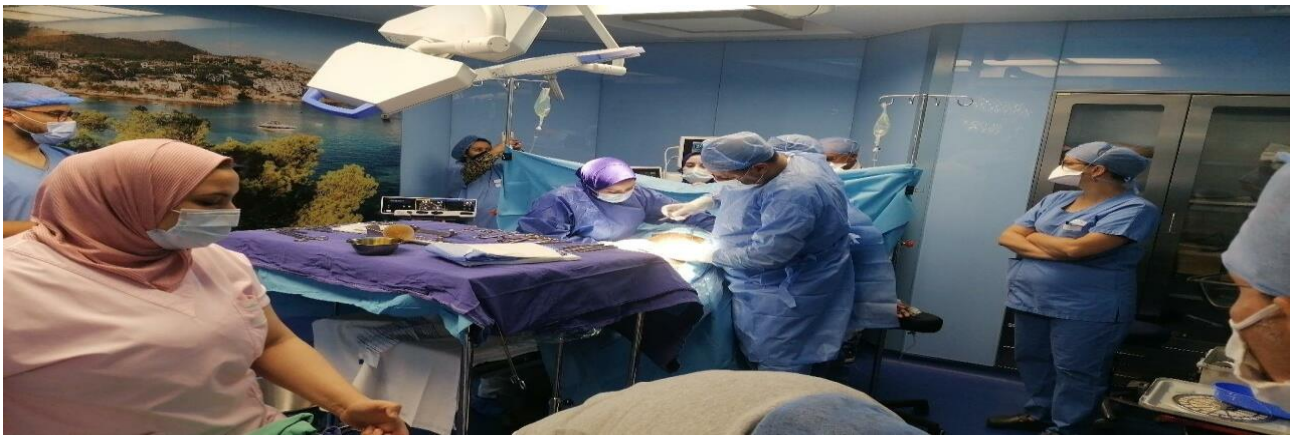
Distance professionnelle et qualité du soin

Pascal Prayez (sous la direction de)

Lamarre éditions, 2018

Collection Fonction cadre de santé

2.5. Le bon positionnement au sein de l'équipe de soins



2.5.1 Caractéristiques d'une équipe soignante

Les équipes soignantes interagissent de manière dynamique vers un objectif commun :

- fournir des prestations de soins aux patients.
- possèdent des connaissances et compétences spécialisées et complémentaires ;
- connaissent chacun leur rôle propre et le rôle des autres membres
- interagissent les uns avec les autres en vue d'atteindre un objectif commun ;
- Prennent des décisions ;
- assument souvent une charge de travail importante ;
- agissent comme un « individu collectif », du fait de l'interdépendance des tâches réalisées par chacun des membres de l'équipe.

2.5.2 La méthode SAED

Définition SAED:

L'outil appelé SAED (Situation, Antécédents, Evaluation, Demande) permet d'améliorer l'orientation téléphonique par les étudiants en médecine dans un environnement simulé.

- Technique permettant de communiquer les informations essentielles sur les préoccupations à l'égard d'un patient qui nécessite une prise en charge et un traitement immédiats.
- Elle vise à assurer que les bonnes informations et le bon niveau de préoccupation sont communiqués au cours d'un échange entre professionnels de santé.

Utilisation dans les situations de communication orale:

- demande verbale d'avis (téléphonique ou non) entre professionnels de santé
- en cas de communications urgentes, par exemple lors de l'aggravation d'un état clinique, ou lors de survenue de complications
- lors du transfert intra ou inter établissements d'un patient
- lors de staff pluriprofessionnel ou multidisciplinaire, afin de structurer la présentation d'un dossier de patient.

Efficacité SAED?

- amélioration de la qualité de la communication entre professionnels de santé,
- amélioration du contenu et de la clarté des informations données,
- meilleure analyse des informations reçues,
- augmentation de la satisfaction des professionnels de santé
- progrès dans le domaine de la communication,
- progrès du travail en équipe
- progrès en termes de culture de sécurité

1- Situation

S'assurer préalablement de l'identité de l'interlocuteur appelé. Préciser :

◊ Son identité (nom, prénom, fonction) ;

◊ Le service d'où on appelle ;

◊ L'identité du patient (nom, prénom, âge du patient) pour lequel on appelle ;

◊ La localisation actuelle du patient (unité, service, etc.) ◊ le lieu où il a été pris en charge par l'interlocuteur (si cela a été le cas) ;

◊ Le motif de l'appel de manière concise ;

◊ La situation actuelle objective motivant l'appel

Exemple:

• « Je m'appelle Sanae, l'infirmière qui suit Mme Laila, salle 4, lit n° 5.
• J'appelle à propos de Mme Laila, chambre 251.
• Elle se plaint principalement d'une dyspnée d'apparition récente. »

2- **Antécédents**

Préciser de manière concise et synthétique :

◊ La date d'admission et le diagnostic posé à l'admission du patient ;

◊ Les antécédents médicaux liés à la prise en charge ;

◊ Les interventions ou examens invasifs réalisés, liés à la prise en charge ;

◊ Les traitements en cours ;

◊ Les allergies connues ;

◊ Les résultats d'examens pertinents (laboratoire, scanner, etc.) ;

◊ L'état habituel du patient (confus, douloureux, etc.) ;

◊ Depuis quand la situation actuelle a évolué. Complémentaires, courriers, etc.).

Exemple:

• « La patiente est une femme de 62 ans, il s'agit du 1er jour post-opératoire après une chirurgie abdominale, elle ne présente aucun antécédent de maladie cardiaque ou pulmonaire.

3- Evaluation

Donner son interprétation :

• de l'évolution de l'état du patient,
• des constantes vitales,
• des signes cliniques,

Exemple

• « Les bruits respiratoires sont diminués côté droit, la patiente dit avoir mal, J'aimerais éliminer un pneumothorax. »

4- **La demande**

• Exprimer de manière claire, précise et concise la demande et les délais en termes de temps.
• Expliquer de manière concise ce dont on a besoin.
• Faites des suggestions.
• Clarifier ses attentes en allant à l'essentiel : quelle est la demande ?

Exemple

• « Je crois vraiment que la patiente devrait être examinée maintenant.
• Pouvez-vous venir immédiatement ? »

• Si le membre de l'équipe soignante n'est pas satisfait de la réponse à sa demande d'examen immédiat, il peut demander de l'aide ou des conseils à une autre personne.

2.5.3Les annonces

Définition

Les annonces sont le moyen de communiquer les informations importantes ou critiques à tous les membres de l'équipe simultanément lors de situations nouvelles.

Cette technique aide les membres de l'équipe à anticiper les étapes suivantes et à confier à une personne donnée la responsabilité de poursuivre la tâche. Voici un exemple d'annonce entre un chef d'équipe et un interne.

Exemple

- Chef d'équipe : Voies aériennes ?
- Interne : Voies aériennes dégagées.
- Chef d'équipe : Bruits respiratoires ?
- Interne : Bruits respiratoires diminués côté droit.
- Chef d'équipe : Tension artérielle ?
- Interne : TA 96/92.

2.5.4- La communication en boucle fermée

Définition:

Technique simple pour garantir que les informations énoncées par l'expéditeur sont bien comprises par le destinataire

• Étape 1 : L'expéditeur initie le message.

• Étape 2 : Le destinataire accepte le message et en répète le contenu.

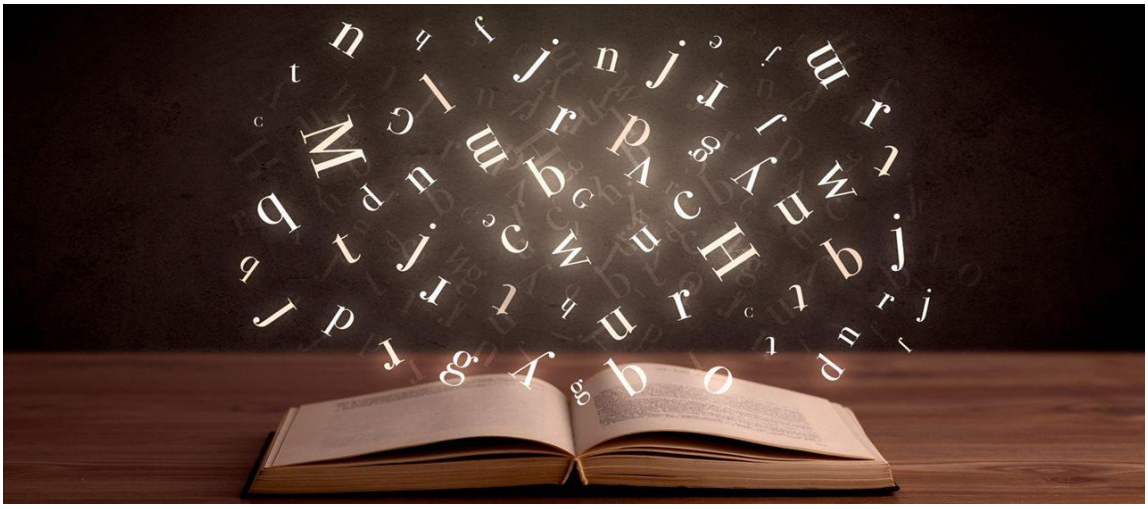
• Étape 3 : L'expéditeur vérifie l'exactitude du message répété pour confirmer qu'il a été bien compris. Exemple:

Médecin : Administrez 20 mg de Solumédrol en bolus IV.

Infirmier(ère) : 20 mg de Solumedrol en bolus IV ?

Médecin : Oui.

Chapitre III
VOCABULAIRE TECHNIQUE



3.1. TERMINOLOGIE MEDICALE

3.1.1 INTRODUCTION

Vous voici au début de votre formation et avec cela vous allez apprendre à vous exprimer de manière à utiliser un langage «universel», qui sera compris par toute personne travaillant dans le domaine de la santé.
Les professionnels paramédicaux et médicaux utilisent un vocabulaire très spécifique qui compte autour de 20 000 mots. L'étude de ses termes s'appelle la terminologie médicale. Un mot médical est une composition de plusieurs unités de sens différents, souvent dérivés de mots grecs et latins.
En utilisant ces termes bien spécifiques, vous pourrez:
- Accéder à une communication plus aisée entre professionnels de santé
- participer à des transmissions plus qualitatives permettant ainsi une meilleure prise en charge de la personne soignée
- avoir la considération des autres membres d'une équipe, être « reconnu »et favoriser votre intégration.

La terminologie n'est pas à utiliser au hasard. Vous devez bien connaître le sens du mot avant de l'utiliser.
Par exemple, vous pourrez parler de colectomie ou de cholécystectomie, en confondant parfois les deux, mais le premier est une intervention sur le colon, l'autre une intervention sur les voies biliaires.

3.1.2 Définitions et Rappels étymologiques : RACINE, PREFIXE, SUFFIXE

Les radicaux, préfixes, suffixes
Le radical ou racine est la partie centrale du mot.
Son sens peut être précisé par
– un préfixe (= placé avant la racine)
– ou un suffixe (= placé après le radical).
Les préfixes et les suffixes s'appellent des **AFFIXES** Affixus, latin = **Attacher**

Les conventions
1. Les préfixes, radicaux et suffixes sont appelés "unités de sens".

2. Le suffixe -ie et les suffixes de forme adjectivale (-ique, -al, -mateux, etc.) font partie de l'unité de sens qui les précède. Ex : douleur = alg(o) ou –algie

3. La dernière unité de sens du mot est appelée "unité opérante". Elle peut être un radical ou un suffixe. C'est elle qui détermine dans quelle catégorie classer le mot (maladie, traitement chirurgical, exploration fonctionnelle, etc.)

4. Les préfixes restent invariables au contact des radicaux auxquels ils se lient, sauf para- et a-, selon qu'ils sont suivi d'une voyelle ou d'une consonne :
   - para + esthésie = paresthésie
   - a + esthésie = anesthésie

5. Les autres unités de sens se lient entre elles par un (o) dit de "liaison phonique". Toutefois, ce (o) est supprimé lorsque l'unité opérante commence par une voyelle.
   - gastr(o) + algie = gastralgie

EXEMPLES des unités de sens les plus utilisées
A ou AN- = absence
BRADY = lent
DYS = fonction anormale
HEMI = moitié
HOMEO = semblable
HYPER = trop, excès, augmentation
HYPO = peu, diminution
PARA = à côté de
PERI = autour
POLY = plusieurs, beaucoup
POST = après, en arrière
PRE = avant, en avant
TACHY = rapide
ALGIE = douleur
ECTOMIE = ablation, exérèse
EMIE = sang, taux sanguin
GRAPHIE = examen radiologique
CENTESE = ponction
ITE = inflammation
LOGIE = étude de
OME = tumeur

OSE = état pathologique chronique
PATHIE = maladie, affection
SCOPIE = examen optique
STOMIE = abouchement chirurgical
TOMIE = ouverture, incision chirurgicale
URIE = taux urinaire, urine

3.1.3 TERMINOLOGIE MEDICALE par catégories

ANATOMIE

TETE	CEPHAL(O)
COU	CERVIC(O)
CHEVEUX, POILS	TRICH(o)
NEZ	RHIN(O)
ŒIL	OCUL(O) ou OPHTALM(O)
OREILLE	OT(O), AURICUL(O)
BOUCHE	STOMATO(O), OS ou OR(O)
GENCIVES	GINGIV(O)
LANGUE	GLOSS(O)- LINGU(O)
MAIN	CHIRO
CORPS	SOMATO
TESTICULE	ORCHI
OS (O)	OSTE
MOELLE	MEDULL(O) ou MYEL(O)
VERTEBRES	SPONDYLO(O)
ARTICULATION	ARTHR(O)
DOS	DORS(O)
POITRINE THORACO	
COLONNE VERTEBRALE	RACHI,RACHID(O)
AINE	INGUIN(O)
HANCHE	COX(O)
GENOU	GON(O)
EXTREMITES	ACR(O)
CŒUR	CARDI(O)
PAUPIERE	BLEPHAR(O)
PLEVRE	PLEURO
VAISSEAUX	ANGI(O) VAS(O), VASCUL(O)
VEINES	PHLEB(O)
TROMPES	SALPING(O)
RATE	SPLEN(O)
REIN	NEPHR(O)
BASSINET	PYEL(O)
URINES	URO
VESSIE	CYST(O)
ESTOMAC	GASTR(O)
FOIE	HEPAT(O)
VESICULE BILIAIRE	CHOLECYSTO(O)
BILE	CHOLE(O)
INTESTIN	ENTER(O)

UTERUS	HYSTER(O) ou METR(O)
VAGIN	COLP(O)
PEAU	DERM(O)
GANGLION	ADEN(O)
TISSUS	HIST(O)
MUSCLE	MY(O)
NERF, SYSTEME NERVEUX	NEVRO, NEURO
FEMME (étude de la)	GYNEC(O)
HOMME (étude de l’	ANDRO
HUMAIN	ANTHROPO
ŒUF	OV(O), OX(O), OXY(O)

BIOLOGIE

BACTERIE DE FORME ARRONDIE	COQUE
CELLULE	CYTE
ETAT DU SANG	HEMIE
IDEE DE SANG	HEMO
ETAT DE L’URINE	URIE
NATURE	PHYSIO
SECRETION	RESE

DIMENSIONS FORMES

LONG, ALLONGEMENT	DOLICHO
DUR	SCLERO
GRAND, IDEE DE DILATATION	MEGA
GRAND	MACRO
PETIT	MICRO
DIMINUTIF	OLE, ULE, ETTE
COURT	STENO

DIMENSIONS FORMES

FORME	MORPHO
QUI A LA FORME DE	IDE
ASPECT DE	OIDE
QUI CONCERNE	IDE
FORMATION	PLASIE
IDEE DE FORMATION	POIESE
QUI FORME	POIETIQUE
FIXATION	PEXIE
VOLUME, NOURRITURE	TROPHIE
ORTHO	DROIT

COULEURS

BLANC	LEUCO
BLEU	CYANO
GRIS	POLIO
NOIR	MELENO
ROUGE	ERYTHRO
VERT	CHLORO
JAUNE	XANTHO
COULEUR	CHROMO

ESPACES OU TEMPS

AUTOUR	PERI
AVANT	PRE
A L'INTERIEUR	ENDO
A TRAVERS	DIA ou PER ou PARA
SOUS, AU DESSOUS	HYPO, SUB
AU DESSUS	EPI
AU MILIEU DE	MEDIA
DANS	EN, IN ou INTRA
EN AVANT	PRO
EN DEHORS DE	EXTRA ou PARA
ENTRE	INTER
AU MILIEU	DE MEDIA
HORS DE	EC OU EX
ABOUCHEMENT CHIRURGICAL	STOMIE
ACCELERATION	TACHY
ARRET	STASE
ECOULEMENT	RHEE
ENSEMBLE, AVEC	SYN OU SYM
JAILLISSEMENT, ECOULEMENT	RRAGIE
MOUVEMENT	KINESO, KINETO
RALENTISSEMENT	BRADY
QUI DECOMPOSE, DETRUIT	LYTIQUE
SECOUSSE	SISMO
FORCE	STENO
IDEE DE DISSOCIATION	LYSE
AVEC	CON, SYN
CAUSE	ETIO
INSUFFISSANCE, DIMINUTION	HYPO
MOIS CYCLES	MENO, MENSTRUO
ESPRIT PSYCHISME	PSYCHO
SENSIBILITE	ESTHESO
SOUVENT	POLLAKI
CYCLES	CYCLO

NEGATIONS / OPPOSITIONS

AUTRE, DIFFERENT	HETERO
CONTRAIRE, ENOUVEAU, AVEC	ANA
MANQUE DE	A, AN
DIFFICULTE	DYS
CONTRE, OPPOSE A	ANTI CONTRA
IDEE DE NEGATION	IN, IM
IDEE D'IMPERFECTION, D'OPPOSITION	PARA
SEMBLABLE	HOMEO, HOMO, IS

PATHOLOGIES

CHAMPIGNON	MYCO
OBSESSION IMPULSIVE	MANIE
FIEVRE, FEU	FEBRO, PYRO, PYRETO
INFECTION	SEPTO, SEPSO
INFLAMMATION	ITE
MALADIE, AFFECTION	PATHO, PATHIE, NOSO
PEUR MORBIDE	PHOBIE
PARALYSIE	PLEGIE

PUS PYO,	PURO
TUMEUR, TUMEFACTION	OME
FENDRE SEPARER	SCHIZO

QUANTITE

INSUFFISANCE, DIMINUTION	HYPO
PEU NOMBREUX	PAUCI
AUGMENTATION DE VOLUME	MEGAL(O)
RARE	ARAIOS
EN EXCES	HYPER
IDEE d'AUGMENTATION	PARA
TROP, AUGMENTATION	HYPER
MOITIE, DEMI	HEMI
PEU	OLIGO
PEUPLE	DEMO
PLUSIEURS, BEAUCOUP	POLY MULTI
PRESQUE	PARA
SEUL	MONO
TROIS	TRI
QUATRE	TETRA

PROCESSUS-BESOINS

VOIX	PHONO
REPETER	ECHO
ECRITURE	GRAPHIE
MOT	LEXIS
FOLIE / DELIRE	MANIE
VOMISSEMENT	EMETO, EMES(O)
CRACHEMENT	PTYSIE
SEC	XERO
RESPIRATION	PNEE
SOMMEIL	HYPNO
TOR PEUR	NARCO
DORMIR	CUBO
PROTECTION	PHYLAXO
MORT	THANA(TO), NECRO
QUI AIME	PHILE
SPECIALISTE DE	LOGUE, LOGISTE
ETUDE DE	LOGIE
POSSEDE DE	AQUE
CONNAISSANCE	GNOSO
ACCOUCHEMENT	TOCO
AFFINITE POUR	TROPE
BIEN, BON, NORMAL	EU
MAUVAIS	CACO
CE QUI EST PRODUIT	PHYSE
QUI TUE	CIDE
CESSATION	PAUSE
DE SOI MEME	AUTO
DE L'AUTRE	ALLO
ETAT, PROCESSUS	OSE
MÉMOIRE	MNESIE
LANGAGE	PHASO/ LALIE

DIGESTION	PEPSO
MANGER	PHAGIE
MOUVEMENT	PRAXIE
SOIF	DIPS
HUMEUR	THYMO
SALIVE	PTUALOS, SIALO
BOIRE	POTO
HALEINE / SOUFFLE	HALITUS

THERAPIE

QUI CALME, SEDATIF	LEPTIQUE
QUI STIMULE	ANALEPTIQUE
ABLATION	ECTOMIE
OUVERTURE, INCISION CHIR, COUPER	TOMIE
EMPLOI THERAPEUTIQUE DE	THERAPIE
MEDICAMENT	PHARMACO
EXAMEN AVEC ENREGISTREMENT	GRAPHIE
INSTRUMENT POUR EXAMINER	SCOPE
RAYON X	RADIO
UNITE DE MESURE D'ACTIVITE D'UNE SOURCE RADIOACTIVE	CURIE
ELECTRICITE	ELECTRO

PSYCHIATRIE

MENSONGE	MYTHO
REVE	ONIRO
ESPRIT	PSYCHO, PHRENO
DIVISION	SCHIZO
SOMMEIL	SOMNO
OBSESSION, FOLIE	MANIE
MIME	MIME
PAROLES, ELOCUTION	PHASIE, PHEMA
LIT	CLINO
ACTION	PRAXIE
CHOC	SISMO

3.2Vocabulaire technique

Vocabulaire médical, du français à l'anglais

Français	Anglais
Abdomen	Abdomen
Accoucher	Te deliver a baby To give birth
Admettre	To admit

Français	Anglais
ADN	DNA
Aider	Help
Aine	Groin
Aisselle	Armpit
Amygdale	Tonsil
Annulaire	Ring Finger
Anus	Anus
Aorte	Aorta
Appendice	Appendix
Apporter	To bring
Arête du nez	Bridge of nose
Artère	Artery
Artère pulmonaire	Pulmonary artery
Articulation	Knuckles
Avant / Devant / de face	Front
Avant-bras	Forearm
Barbe	Beard
Bas du dos	Lower back
Bassin	Pelvis
Bronche(s)	Bronchus / bronchi
Bronchiole	Bronchiole
Cage thoracique	Rib cage
Cartilage	Cartilage
Cavite nasale	Nasal cavity
Ceinture pelvienne	Girdle pelvic
Cérumen / cire	Ear wax
Cerveau	Brain Cerebrum
Cervelet	Cerebellum
Chauve / Calvitie	Bald / Baldness
Cheville	Ankle
Cils	Eyelashes
Clavicule	Clavicle
Cœur	Heart
Col de l'utérus	Cervix
Colon	Colon
Colonne vertébrale	Spine / Backbone / Spinal / Vertebral Column
Conduit	Canal
Corde vocale	Vocal cord
Corps / organisme	Body
Cote	Rib
Cou	Neck
Coude	Elbow
Coup-de-pied	Instep
Crane	Skull
Cubitus / Ulna	Ulna
Cuir chevelu	Scalp

Français	Anglais
Cuisse	Thigh
Dent / dents	Tooth / Teeth
Diaphragme	Diphragm
Doigt	Finger
Doigt de pied	Toe
Dos	Back
Droit / a droite	Right
Duodénum	Duodenum
Entrailles	Insides
Epaule	Shoulder
Estomac / ventre	Stomach
Favoris / pattes	Sideburns
Fémur	Femur
Foie	Liver
Fonctions physiologiques	Bodily functions
Front	Forehead
Gauche	Left
Gencives	Gums
Genou	Knee
Gland	Glans
Glandes salivaires	Salivary glands
Glandes surrénales	Adrenal glands
Globe oculaire	Eyeball
Gorge	Throat
Grain de beauté	Mole / beauty spot
Gros intestin	Large intestine
Hanche	Hip
Haut du bras	Upper arm
Humérus	Humerus
Ilion	Ileum
Imberbe	Hairless
Index	Index finger
Intestin grêle	Small instestine
Intestins	Bowels
Iris	Iris
Jambe	Leg
Joue	Cheek
Langue	Tongue
Larynx	Larynx
Lèvre	Lip
Ligament	Ligament
Lobe	Earlobe
Mâchoire	Jaw
Main	Hand
Majeur	Middle finger
Mamelon	Nipple
Mélanine	Melanin

Français	Anglais
Membre	Limb
Menton	Chin
Moelle épinière	Spinal cord
Mollet	Calf
Moustache	Mustache
Muqueuse	Mucous membrane
Muscle	Muscle
nal lacrymal	Tear Duct
Narines	Nostrils
Nerf	Nerve
Nerf périphérique	Peripheral nerve
Nez	Nose
Nombril	Belly Button Navel
Nuque	Nape
Œsophage	Esophagus
Ombilic	Umbilicus
Omoplate / Scapula	Scapula
Omoplate Scapula	Shoulder Blade
Ongle	Fingernail Nail
Ongle de pied	Toenail
Oreille	Ear
Organe vital	Vital organ
Orifice de l'oreillette droite	Right atrium / auricle
Ovaire	Ovary
Palais	Palate
Pancréas	Pancreas
Parties génitales / organes génitaux	Genitalia / genitals
Parties génitales/intimes	Privates
Paume	Palm
Paupiere	Eyelid
Peau / épiderme Couche de la peau	Skin / epidermis Skin layers
Péroné / Fibula	Fibula
Petit doigt	Little finger
Petit orteil	Pinky toe
Phalange	Phalange / Phalanx
Pharynx	Pharynx
Pied	Foot
Pied / pieds	Foot / feet
Pilosité Faciale	Facial hair
Plante de pieds	Sole of the foot
Poignet	wrist
Poil / cheveux	Hair
Poing	Fist
Poitrine	Chest

Français	Anglais
Pomme d'Adam	Adam's apple
Postérieur / fesses	Buttocks / bottom
Pouce	Thumb
Poumon	Lung
Pubis	Pubis
Pupille	Pupil
Radius	Radius
Raie des fesses	Cleft of the buttocks
Rate	Spleen
Rectum	Rectum
Rein	Kidney
Reins	Loin
Rotule / Patella	Patelle
Salive	Saliva
Sang	Blood
Scrotum	Scrotum
Sein	Breast
Semence	Semen
Sourcil	Eyebrow
Sperme	Sperm
Sphincter	Sphincter
Sternum	Sternum
Système nerveux autonome	Automatique nervous system
Système nerveux central	Central nervous system
Taches de rousseur	Freckles
Taille	Waist
Talon	Heel
Tendon	Tendon
Testicule	Testicle / testis
Tète	Head
Thorax	Thorax
Trachée	Windpipe / Trachea
Thyroïde	Thyroid
Tibia	Shin / tibia
Tour de taille	Waistline
Trompes de Fallope	Fallopian tubes / oviducts / uterine tubes
Tronc	Trunk
Tympan	Eardrum
Uretère	Ureter
urètre	Urethra
Utérus	Uterus
Vagin	Vagina
Vaisseaux	Vessels
Valve	Valve
Veine	Vein
Veine cave inferieur VCI	Inferior vena cava IVC
Veine cave supérieure VCS	Superior vena cava SVC

Français	Anglais
Veine pulmonaire	Polmonary vein
Ventre	Belly
Ventricule droit	Right ventricle
Ventricule gauche	Left ventricle
vertèbre cervicale	Cervical vertebra
vertèbre(s)	Vertebra(e)
Vésicule biliaire	Gall-bladder
Vessie	Bladder
Voies respiratoires	Airway
Vulve	Vulva

EBascule français – anglais sur les abréviations médicales

Une version anglaise des sigles a été mise en ligne par l'ordre des physiothérapeutes canadiens :

Elle peut être consultée sur https://oppq.qc.ca/wp-content/uploads/Abreviation-medicale-fr-eng.pdf

Elle est très (trop) complète : nous conseillons de la garder en documentation mais pour l'usage courant, lors de contact avec un public international anglophone, de faire avec le formateur une sélection (au feutre Stabilo)